

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5086123-04.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: AFRANIO DE OLIVEIRA CAVALCANTI

RECORRIDO: ROBERTO MARINHO CAVALCANTI

MEDIDA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. PARECER DO NAT. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A TAL RECURSO. RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso e ratifico a decisão que indeferiu a liminar, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2024.

5086123-04.2024.4.02.5101

510014912347 .V7

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5086123-04.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: AFRANIO DE OLIVEIRA CAVALCANTI

RECORRIDO: ROBERTO MARINHO CAVALCANTI

RELATÓRIO

Trata-se de Medida de Urgência, na qual a União objetiva atribuir efeito suspensivo à decisão proferida nos autos originários de nº 5079099-22.2024.4.02.5101 (Evento 8, DESPADEC1) pelo Juízo Titular da 34ª Vara Federal do Rio de Janeiro que determinou o fornecimento da Oxigenoterapia Domiciliar, com concentrador de oxigênio estacionário, concentrador de oxigênio móvel e cilindro de alumínio para uso de 24 horas por dia a 01 litro/min, tal como consta no parecer do NAT (Evento 6, PARECER1).

A liminar foi indeferida (Evento 3).

A parte autora apresentou contrarrazões (evento 14).

É o breve relatório.

VOTO

Pois bem, no caso em tela não houve modificação do contexto fático-probatório capaz de alterar o entendimento proferido na decisão do Evento 3, a qual passa a integrar o presente voto:

"DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de medida de urgência interposta pela União em face da decisão, verbis:

*"Trata-se de ação proposta por **Afranio de Oliveira Cavalcanti**, representado por **Roberto Marinho Cavalcanti**, contra a **União**, o **Estado do Rio de Janeiro** e o **Município do Rio de Janeiro**, com pedido de tutela de urgência, objetivando a condenação dos réus ao fornecimento da Oxigenoterapia Domiciliar, com concentrador de oxigênio estacionário, concentrador de oxigênio móvel e cilindro de alumínio para uso de 24 horas por dia a 01 litro/min.*

*Breve relatório. **Decido.***

A tutela de urgência exige a presença dos seguintes requisitos: probabilidade do direito, lastreado em prova inequívoca e que haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Novo CPC.

Ressalte-se que é dever do Estado garantir, mediante a implantação de políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário à saúde, bem como os serviços e medidas necessários à sua promoção, proteção e recuperação, conforme artigo 196 da CF.

No caso dos autos, os documentos médicos oriundos do serviço de pneumologia do Hospital Federal Cardoso Fontes (evento 1 - ANEXO2) demonstram que a demandante é portadora de doença pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida e doença renal crônica em tratamento conservador. Apresenta quadro de insuficiência respiratória crônica e permanece dependente de oxigenoterapia com saturação de O2 em 84% em ar ambiente em repouso.

A Câmara de Resolução de Litígios em Saúde informa que a Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada não se encontra disponível em nenhuma lista de dispensação de insumos do SUS, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, muito embora esteja indicada para o manejo do caso em questão (Evento 1 - ANEXO2).

Ressalto que o NAT, em seu parecer, informou que o tratamento com Oxigenoterapia domiciliar e cateter nasal estão indicados para o quadro clínico que acomete o autor e está coberto pelo SUS, está recomendada a sua incorporação para pacientes com Doenças Pulmonar Obstrutiva Crônica como no quadro do autor.

Acrescenta que caso haja aquisição dos equipamentos, o autor deverá ser acompanhado por médico especialista, a fim de que sejam realizadas orientações e adaptações acerca da utilização dos referidos equipamentos, bem como ser submetido a reavaliações clínicas periódicas.

Esclarece que, no âmbito do município e do estado do Rio de Janeiro, não foi localizada nenhuma forma de acesso pela via administrativa ao tratamento com oxigenoterapia domiciliar, bem como não foram identificados outros equipamentos que possam configurar uma alternativa terapêutica (Evento 6).

Tem-se, portanto, que existe apenas um meio disponível para que a autora seja tratada.

O periculum in mora é evidente, tendo em vista que, conforme documento médico que acompanha a inicial, a autora apresenta dessaturação importante em ar ambiente.

Dessa forma, tendo sido demonstrada a necessidade urgente dos equipamentos e insumos para tratamento da doença que acomete a autora, entendo presentes os requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela.

Assim, **defiro a tutela de urgência**, com fulcro no art. 4º, da Lei nº 10.259/01, c/c art. 300 do Novo Código de Processo Civil, e **determino aos réus, solidariamente**, que forneçam à parte autora, **no prazo de 5 (cinco) dias**, o tratamento de **Oxigenoterapia Domiciliar**, nas modalidades estacionária e portátil com concentrador de oxigênio estacionário, concentrador de oxigênio móvel e cilindro de alumínio para uso de 24 horas por dia a 01 litro/min, nos termos dos documentos médicos que acompanham a inicial.

Considerando a necessidade de avaliação periódica, conforme exposto pelo NAT, a cada 03 (três) meses, deverá ser apresentado novo documento médico sobre a necessidade da utilização do tratamento vindicado pela autora.

Citem-se os réus para apresentar contestação, no prazo legal, contado em dias úteis, instruindo a peça com os documentos necessários ao deslinde do feito e prestando as informações acerca dos insumos objetos da lide, e **intime-os desta decisão para cumprimento**.

Suspenda-se o curso do processo até apresentação de resposta ou decurso do prazo, por se tratar de prazo superior a 30 dias corridos.

Intime-se a DPU.

Defiro a gratuidade de justiça

Defiro o pedido de prioridade dos atos processuais em função da idade."

A União requereu o efeito suspensivo e a cassação da antecipação dos efeitos da tutela. Na eventualidade de manutenção da tutela provisória de urgência, o direcionamento do cumprimento da ordem judicial ao Município.

É o breve relatório.

Pois bem, sabe-se que são requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência: a) a probabilidade do direito pleiteado, ou seja, uma plausibilidade lógica que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, do que decorre um provável reconhecimento do direito, baseada em uma cognição sumária; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso não concedida, ou seja, quando houver uma situação de urgência em que se não se justifique aguardar o desenvolvimento natural do processo sob pena de ineficácia ou inutilidade do provimento final.

No caso, a parte autora comprovou todos os requisitos.

A parte autora comprovou ser portadora de doença pulmonar obstrutiva crônica, com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida e doença renal crônica.

Foi realizada, corretamente, a intimação do Núcleo de Assistência Técnica, NAT, para emissão de parecer, nos termos do que dispõe o Enunciado 13 do CNJ: "Nas ações de saúde que pleiteiam o fornecimento de medicamentos, produtos ou tratamentos, recomenda-se, sempre que possível, a prévia oitiva do gestor do Sistema Único de Saúde - SUS, com vistas a, inclusive, identificar solicitação prévia do requerente, alternativas terapêuticas e competência do ente federado, quando aplicável (Saúde Pública e Suplementar). (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)"

O NAT juntou parecer no processo 5079099-22.2024.4.02.5101/RJ, evento 6, PARECER1.

Trata-se de Autor, de 85 anos de idade, **ex-tabagista**, portador de **doença pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida e doença renal crônica em tratamento conservador**. Encontra-se internado no Hospital Federal Cardoso Fontes, necessitando de **suplementação de oxigênio contínua em regime domiciliar – modalidade estacionária (concentrador de oxigênio + cilindro de oxigênio líquido para back-up em caso de falta de energia) e modalidade portátil (concentrador de oxigênio portátil ou cilindro de alumínio com oxigênio gasoso comprimido)** (Evento 1, ANEXO2, Página 11). Foi pleiteado o tratamento com **oxigenoterapia domiciliar (concentrador de oxigênio estacionário + concentrador de oxigênio portátil + cilindro de alumínio)** (Evento 1, INICI, Página 10).

Informa-se que o tratamento com **oxigenoterapia domiciliar (concentrador de oxigênio estacionário + concentrador de oxigênio portátil + cilindro de alumínio)** pleiteado **está indicado** ao manejo terapêutico do quadro clínico que acomete o Requerente (Evento 1, ANEXO2, Página 11).

O referido tratamento **é coberto pelo SUS**, conforme Tabela Unificada do Sistema de Gerenciamento de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS – SIGTAP, na qual consta **oxigenoterapia**, sob o código de procedimento: 03.01.10.014-4, para área ambulatorial, hospitalar e de **atenção domiciliar**, uma vez que a CONITEC avaliou a incorporação da **oxigenoterapia domiciliar, estando recomendada a incorporação para pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)**¹ – o que **se enquadra** ao quadro clínico do Assistido (Evento 1, ANEXO2, Página 11).

Considerando que é de responsabilidade do médico determinar a necessidade e a forma de administração do oxigênio, caso haja a aquisição dos equipamentos para o tratamento com **oxigenoterapia pleiteado**, o Autor deverá ser acompanhado por médico especialista, a fim de que sejam realizadas orientações e adaptações acerca da utilização dos referidos equipamentos, bem como ser submetido a **reavaliações clínicas periódicas**.

Cabe esclarecer que, até o presente momento, no âmbito do município e do Estado do Rio de Janeiro, **não foi localizada nenhuma forma de acesso pela via administrativa ao tratamento com oxigenoterapia domiciliar** pleiteado, bem como não foram identificados outros equipamentos que possam configurar uma alternativa terapêutica.

Trata-se de Autor, de 85 anos de idade, **ex-tabagista**, portador de **doença pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida e doença renal crônica em tratamento conservador**. Encontra-se internado no Hospital Federal Cardoso Fontes, necessitando de **suplementação de oxigênio contínua em regime domiciliar – modalidade estacionária (concentrador de oxigênio + cilindro de oxigênio líquido para back-up em caso de falta de energia) e modalidade portátil (concentrador de oxigênio portátil ou cilindro de alumínio com oxigênio gasoso comprimido)** (Evento 1, ANEXO2, Página 11). Foi pleiteado o tratamento com **oxigenoterapia domiciliar (concentrador de oxigênio estacionário + concentrador de oxigênio portátil + cilindro de alumínio)** (Evento 1, INICI, Página 10).

Informa-se que o tratamento com **oxigenoterapia domiciliar (concentrador de oxigênio estacionário + concentrador de oxigênio portátil + cilindro de alumínio)** pleiteado **está indicado** ao manejo terapêutico do quadro clínico que acomete o Requerente (Evento 1, ANEXO2, Página 11).

O referido tratamento **é coberto pelo SUS**, conforme Tabela Unificada do Sistema de Gerenciamento de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS – SIGTAP, na qual consta **oxigenoterapia**, sob o código de procedimento: 03.01.10.014-4, para área ambulatorial, hospitalar e de **atenção domiciliar**, uma vez que a CONITEC avaliou a incorporação da **oxigenoterapia domiciliar, estando recomendada a incorporação para pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)**¹ – o que **se enquadra** ao quadro clínico do Assistido (Evento 1, ANEXO2, Página 11).

Considerando que é de responsabilidade do médico determinar a necessidade e a forma de administração do oxigênio, caso haja a aquisição dos equipamentos para o tratamento com **oxigenoterapia pleiteado**, o Autor deverá ser acompanhado por médico especialista, a fim de que sejam realizadas orientações e adaptações acerca da utilização dos referidos equipamentos, bem como ser submetido a **reavaliações clínicas periódicas**.

Cabe esclarecer que, até o presente momento, no âmbito do município e do Estado do Rio de Janeiro, **não foi localizada nenhuma forma de acesso pela via administrativa ao tratamento com oxigenoterapia domiciliar** pleiteado, bem como não foram identificados outros equipamentos que possam configurar uma alternativa terapêutica.

O NAT, em seu parecer, informou que o tratamento com Oxigenoterapia domiciliar e cateter nasal estão indicados para o quadro clínico que acomete o autor e está coberto pelo SUS, está recomendada a sua incorporação para pacientes com Doenças Pulmonar Obstrutiva Crônica como no quadro do autor.

De tal sorte, comprovada a impossibilidade de arcar com os custos da medicação/insumo, a essencialidade, a urgência e a impossibilidade de substituição dos medicamentos/insumos por qualquer outra alternativa terapêutica, resta configurado o dever das rés quanto ao fornecimento do insumo/fármaco/aparelho a parte autora.

Ainda, no que toca à irreversibilidade dos efeitos de uma possível decisão satisfativa tomada neste momento, calha ressaltar que a não concessão da tutela antecipada teria efeitos muito mais graves, deletérios e permanentes do que a eventual despesa financeira que o Poder

Público possa ter.

*Quanto ao tema, cabe mencionar o enunciado 40 da I Jornada de Direito Processual Civil, que assim dispôs: "**ENUNCIADO 40** - A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível."*

Portanto, afigura-se mais adequado para solucionar o conflito entre o direito à saúde e a capacidade orçamentária do Poder Público, que o tratamento médico seja fornecido à parte autora.

O parecer também esclareceu que até o presente momento, no âmbito do município e do Estado do Rio de Janeiro, não foi localizada nenhuma forma de acesso pela via administrativa ao tratamento com oxigenoterapia domiciliar pleiteado, bem como não foram identificados outros equipamentos que possam configurar uma alternativa terapêutica. Também afirmou que não existem Programas nas três esferas governamentais que venham atender as necessidades terapêuticas de fornecimento de oxigenoterapia domiciliar, que verse sobre o quadro de doença pulmonar obstrutiva crônica.

O Tema 793, estabeleceu que "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (RE 855178, em 23.05.2019).

Na mesma direção, os enunciados 8, 60, 87 CNJ trataram, respectivamente, do respeito à repartição de competências entre os entes, da necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação a um dos entes e da individualização da atribuição dos entes.

Assim, a responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Considerando que o parecer afirmou que não existem programas governamentais para atender as necessidades terapêuticas da parte autora, o cumprimento da obrigação deverá ser direcionado a todos os entes.

*Por essas razões, **indefiro o requerimento de natureza cautelar de atribuição de efeito suspensivo**. Intimem-se.*

Após, à conclusão para voto."

Logo, a decisão concessiva atacada observou corretamente o preenchimento dos requisitos legais e não há algum *periculum in mora* inverso ou argumento relacionado a questões de ordem pública relevante que autorize a concessão da pretendida suspensão da decisão.

Por tais razões, voto por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** ao recurso e ratifico a decisão que indeferiu a liminar.